

09 - 09- Présentations Céphaliques Défléchies - Pr. SOUMMANI

Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un autre chapitre d'obstétrique concernant les présentations céphaliques des fléchis. Comme leur nom l'indique, les présentations céphaliques des fléchis sont des présentations certes céphaliques comme pour la présentation du sommet, mais dans le sommet où la présentation est complètement fléchie, dans les présentations céphaliques des fléchis, la tête est en déflexion. Et donc, au total, les présentations céphaliques des fléchis sont des présentations céphaliques autres que le sommet.

Ce sont des présentations du travail, donc il ne faut jamais parler de présentations céphaliques des fléchis au cours de la grossesse. Pourquoi ? Parce que, le plus souvent, même dans les présentations du sommet, la tête ne se fléchit qu'au cours du travail. Ce sont des présentations qui sont rares, constituent moins d'un pour cent des accouchements.

On va éliminer dans ce chapitre les morts nés macérés, les âmes encéphales et la grande prématurité parce qu'ils sont le plus souvent favorables à un accouchement. La présentation de la face est une parmi les présentations céphaliques des fléchis. Il y a la présentation du front et la présentation de l'eigma qui sont des présentations dystoxiques.

La présentation de la face est une présentation qui est eutoxique à condition que le menton tourne en avant. Aucun accouchement ne peut se faire si le menton ne tourne pas en avant. Les objectifs de cette question, c'est d'abord les définitions, les étiologies diagnostiques de chaque présentation, le mécanisme obstétrical, et ici on va prendre le mécanisme obstétrical de l'accouchement de la face puisque c'est elle qui est eutoxique, donc les complications et les conduites obstétricales.

La présentation de la face se définit comme étant une présentation céphalique des fléchis avec une tête qui est complètement défléchie de telle sorte que l'occipute entre au contact avec le dos. La présentation du front, c'est une présentation où la déflexion est partielle de la tête qui se fixe de façon définitive et fait pénétrer dans le détroit supérieur une partie plus ou moins voisine du front, selon Lacan. La présentation bregma est une déflexion légère entre la déflexion complète qui est la présentation de la face et la présentation du front qui est la présentation avec une déflexion partielle.

Voilà comment vont se présenter. Ici il y a à gauche sur la photo la présentation de la face où la tête est complètement défléchie et notez que l'occipute est au contact avec le dos. Par contre le front c'est une présentation partielle, intermédiaire.

La présentation du siège et la présentation de l'épaule. Les étiologies ce sont des présentations qui sont rares. 0,1 à 0,3% moins pour le front.

La fréquence est très variable qui peut aller de 0,5 à 10 pour mille accouchements. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont diagnostiquer à tort une présentation défléchie alors qu'elle n'est

pas encore fixée. Les facteurs favorisants sont d'abord d'ordre maternel, la grande parité, les anomalies du bassin.

Il y a également les causes fœtales telles que la macrosomie et les malformations. Et les causes ovulaires, l'hydramnios, le placenta préfixé et les anomalies du cordon ombilical. Soit un cordon court, soit un cordon qui est lent.

Le diagnostic, comment faire le diagnostic des présentations céphaliques défléchies ? Nous allons prendre la présentation de la face comme type de description puisque c'est une présentation qui est plus fréquente que les autres et qui peut accoucher normalement à condition que le menton tourne en avant. Au cours du travail, à l'inspection, la présentation est longitudinale comme pour le sommet, comme pour le siège. La palpation, nous allons trouver une tête qui est au niveau du pelvis mais qui est aussituée, elle est dure, proéminente, qui déborde la symphyse pubienne vu que la tête est en déflexion.

On va aller chercher le plan du dos qui est dans le même côté que la proéminence de la tête. Et entre la tête et le dos, vous allez trouver un coup de hache, c'est-à-dire un sillon assez marqué entre la tête et le plan du dos. Le toucher vaginal, surtout, le plus souvent, la présentation est aussituée et on a du mal à faire le diagnostic.

Lorsque le toucher vaginal accède à la présentation, d'un côté, vous allez trouver le front, les arcades orbitaires et le nez qui est au centre de la présentation. Et puis, vous allez trouver la bouche et le menton. Le menton, c'est le repère de la présentation.

Quelques examens complémentaires, vous pouvez faire un profil fœtal par une radio de contenu utérin qui va montrer une déflexion de la tête complète. Et l'échographie obstétrique, vous pouvez également trouver une tête qui est défléchie. Il faut prendre quelques diagnostics différentiels.

La présentation du siège, au lieu des joues, on va trouver les fesses et au lieu de la bouche, on va trouver la bouche. La présentation du front également, il y a des difficultés de faire le diagnostic entre la face et le front. Dans la présentation du front, on ne touche pas le menton.

Par contre, dans la présentation de la face, on trouve le menton. Il y a également une présentation du sommet avec une bosse séro-sanguine qui va faire disparaître les repères des présentations. Comment va se dérouler l'accouchement ? J'ai dit que le repère de la présentation est le menton.

C'est le menton qui va définir, en fonction de sa position par rapport au détroit supérieur, les variétés. Les variétés peuvent être antérieures, postérieures ou transverses. Les variétés antérieures, soit à gauche, donc menton à gauche antérieure, menton à droite antérieure, menton pubien, c'est-à-dire le menton est en rapport avec le pubis.

Les variétés postérieures, soit montant il y a gauche postérieure, montant il y a droite postérieure, montant sacré, qui sont rares. Et les variétés transversales, où le montant est dans une position transverse, ce sont des variétés postérieures qui sont en train de tourner pour devenir antérieures. Le diamètre de la présentation de la fosse, c'est le sous-montant brigmatique.

Ce diamètre sous-montant brigmatique mesure 9,5 cm, donc favorable à un diamètre oblique de détroit supérieur, qui mesure respectivement 12 à 12,5 cm. Mais le problème, c'est que la tête est en déflexion complète. L'occipite touche le dos, donc ce qui se présente au détroit supérieur, c'est un bloc thorax et tête.

Et donc, c'est un diamètre sensipito-presternal, c'est-à-dire du front jusqu'au niveau du presternal. Ce diamètre mesure 13 à 15 cm, donc incompatible avec un accouchement, incompatible de traverser le détroit supérieur. J'ai dit que les obliques ne mesurent pas plus de 12,5 cm.

Donc, pour que l'accouchement se fasse, il faut obligatoirement une désolidarisation tête et tronc. Il faut que la tête se désolidarise avec le tronc. Pour, au lieu d'avoir un diamètre de 13 à 15 cm sensipito-presternal, nous allons avoir un sous-montant brigmatique.

Donc, rappelez-vous que je vous ai dit, dans la présentation du siège, que la tête doit être solidaire au tronc. Ici, c'est l'inverse. La tête doit se désolidariser du tronc pour qu'il y ait un accouchement.

Il faut savoir que dans la face, contrairement aux autres présentations, dans la présentation de la face, l'engagement descente et dégagement se font pratiquement en même temps. Donc, le montant doit, pour qu'il y ait un accouchement, le montant doit tourner en avant. Pourquoi ? Parce que, si elle tourne en avant, le montant peut passer sous la symphyse pubienne.

Et une fois sous la symphyse pubienne, il y a de l'espace pour que la tête fasse sa flexion et fasse son accouchement. Donc, pour qu'il y ait un accouchement normal, il faut que le montant tourne en avant. Pour avoir une désolidarisation de la tête du tronc, le montant en avant, l'occipite dans l'exclamation en arrière.

Dans les variétés postérieures, sous l'effet de la contraction utérine, la première phase, c'est l'occipite. Je parle ici de variétés postérieures. L'occipite est en avant, donc il va buter sous l'effet de la contraction utérine sur la symphyse pubienne.

Puis, il y aurait un blocage par le thorax et les épaules. Donc, sous l'effet de la contraction, on va obliger la présentation de tourner. Il va se faire pratiquement 135 degrés et le montant devient antérieur.

Lorsqu'il devient antérieur, qu'est-ce qu'il va faire ? Toujours sous l'effet de la contraction utérine,

le montant va glisser sous la symphyse pubienne. Une fois qu'il glisse sous la symphyse pubienne, il y aura une élongation du cou pour que la longueur du cou soit pratiquement égale à la longueur de la symphyse pubienne. Et dans ce cas, on aura de l'espace, le montant aura de l'espace et la tête va faire sa flexion et va se désolidariser du tronc.

Donc, cette flexion de la tête ne peut se faire que si le montant tourne en avant. Et puis, lorsque la tête va se fléchir, on voit apparaître au niveau de la vulve les arcades orbitaires, le front, les fontanelles antérieures puis postérieures et l'occiput et l'accouchement de la tête va se faire. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'au même moment, il va y avoir un engagement descente avec élongation du cou.

Le montant glisse sous la symphyse pubienne, il va se mettre au-dessous de la symphyse pubienne, la tête va se fléchir et l'accouchement va se faire. Dans les variétés antérieures, le temps est moins long puisque la rotation n'est que de 45° et dans les montants pubiens, il n'y a pas de rotation parce que le montant est en rapport avec la symphyse pubienne. Voilà ce qui va se faire.

Le montant doit être en avant. Si le montant est en arrière, on aura un enclavement. Lorsque le montant est en avant, regardez l'image à droite, une élongation du cou, le montant va être au-dessus de la symphyse pubienne, la flexion de la tête va se faire, il va permettre une désolidarisation et l'accouchement se fait sans aucun problème.

Les différentes variétés de la présentation de la face. Quelques explications par des liens au niveau de Youtube, vous pouvez trouver ça, c'est en anglais mais c'est facile à comprendre. Quelles sont les complications de l'accouchement de la face ? Les complications maternelles, c'est d'abord l'augmentation du taux de césarienne.

Les complications périnatales, c'est une morbidité très élevée par rapport à la présentation du sommet. La présentation de la face va donner un aspect particulier au nouveau-né. C'est un nouveau-né qui va être un opistotonos, c'est-à-dire vu que c'était une déflexion complète de la tête, donc il y aura une rétraction des muscles sternoclédomastoidien et qui va disparaître par la suite.

Une lordose dorsale, une tête défléchie. Il y a également une dolicocephalie. Il y a le cri qui est roc parce que vu la déflexion importante, on a un œdème au niveau des voies respiratoires.

Des œdèmes des lèvres et de la face et ce sont des œdèmes qui sont beaucoup plus dus au toucher vaginal de personnel soignant. Mais il faut rassurer la femme et lui dire que cet aspect va disparaître au bout de 24-48 heures. Il y a également une augmentation du taux des extractions instrumentales.

Si le montant ne tourne pas en avant, s'il reste postérieur sous l'effet de la contraction, il va s'enclaver dans l'excavation. Il ne peut plus faire sa rotation et il peut entraîner une rupture

utérine, un décès foetal, une souffrance foetale aiguë, une endométrie de poste partante parce qu'on aura à faire beaucoup de manœuvres et il y aura également la possibilité de déchirure pérenniale. Notre conduite obstétricale serait comme suit.

D'abord la surveillance du travail. Il faut s'attendre à un travail qui est lent parce que dans les variétés postérieures, lorsque le montant est postérieur, on doit attendre qu'il tourne en avant. Il y a fréquemment des dystocies dynamiques.

L'engagement ne se fait en général qu'à dilatation complète. Il faut surveiller le rythme cardiaque foetal, surveiller la dilatation. Si le montant est antérieur d'emblée, l'accouchement est plus facile.

Les indications d'emblée à une césarienne, c'est la macrosomie, les anomalies du bassin. Dans ces cas, il ne faut pas attendre la fin du travail, mais il faut indiquer une césarienne. Si le montant ne tourne pas en avant, c'est-à-dire on donne un peu de temps à la femme pour que les contractions utériennes agissent au niveau de la présentation et que le montant tourne en avant.

Combien de temps il faut attendre pour dire que ce montant ne va pas tourner en avant ? En général, on attend jusqu'à 3-4 cm. Si à 3-4 cm, avec des bonnes contractions utériennes et le montant ne tourne toujours pas en avant, dans ce cas, on arrête le travail et on fait une césarienne. Il y a également les dystocies dynamiques.

S'ils ne répondent pas aux perfusions d'ocytocine, il faut faire une césarienne. Les autres présentations céphaliques déficient. Il y a le franc.

Le repère de la présentation du franc est la racine du nez. Le diamètre de la présentation est le syncypite montonnier qui mesure 13,5 cm, donc impossible qu'il dépasse le détroit supérieur. Les variétés soient antérieures ou postérieures.

Il n'y a ni droit transverse, ni gauche transverse, ni droit antérieur, ni gauche antérieure, etc. L'engagement est impossible et il est inacceptable. Lorsque la présentation est une présentation du franc, je répète que dans cette présentation, on ne touche pas le montant, donc on sait que ce n'est pas une présentation de la face.

On attend que le franc se fixe et lorsqu'il est fixé, d'ailleurs, par définition, il doit être fixé pour parler de présentation du franc, dans ce cas, on indique une césarienne. Le diagnostic, après la rupture des membranes, le franc est perçu au milieu de l'excavation. D'un côté, on va trouver les grandes fontanelles avec ses quatre angles.

De l'autre côté, la racine du nez qui est une saillie pyramidale qui est dure, donc même s'il y a une bosse sérosanguine, vous allez trouver cette saillie pyramidale dure qui est la racine du nez. La bouche et le montant ne sont jamais atteints et la césarienne est indiquée d'angle. Dans la présentation Bregma, le repère de la présentation est la grande fontanelle.

Le diamètre est l'occipito frontal. L'occipito frontal mesure 12 cm. Mais puisqu'on indique que le

détroit supérieur a un oblique de 12 et un oblique de 12,5, vous allez trouver qu'il peut passer à travers le détroit supérieur, mais il va passer difficilement et on peut avoir des accidents obstétricaux, surtout des traumatismes crâniens.

Donc c'est pour ça qu'il faut éviter un accouchement normal, sauf si c'est une grande prématurité. Dans ce cas, j'ai dit que ça ne fait pas partie de notre chapitre. Le diagnostic, c'est toujours au cours du travail, après rupture des membranes, on trouve la grande fontanelle au centre, on trouve la petite fontanelle, on ne trouve pas, pardon, on trouve la grande fontanelle, jamais on ne perçoit la petite fontanelle, ni la racine du nez, comme dans la présentation du frère.

L'accouchement est possible puisque le diamètre est de 12 cm, mais potentiellement distaussé, donc il vaut mieux faire une césarienne.